



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT
DARURAT (IGD)**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 319.30/I-PDM/IGD/IV/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) ini yang dipergunakan pada tahun 2025 meliputi system dan alur pelayanan IGD di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan instalasi Gawat Darurat (IGD) ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN IGD 2025

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
PERATURAN DIREKTUR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PEDOMAN	1
1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN	1
1.4 BATASAN OPERASIONAL	1
BAB II STANDAR KETENAGAAN	3
2.1 KUALIFIKASI SDM	3
2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN	3
2.3 PENGATURAN JAGA	4
BAB III STANDAR FASILITAS	5
3.1 DENAH RUANGAN	5
3.2 STANDAR FASILITAS	5
3.3 PERSYARATAN SARANA	5
3.4 PRASARANA MEDIS	6
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	12
4.1 PELAYANAN RAWAT INAP YANG BISA DILAKUKAN DI RSPH	12
4.2 PELAYANAN RAWAT INAP YANG TIDAK BISA DILAKUKAN DI RSPH	12
BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN	13
5.1 SKRINING PASIEN	13
5.2 ADMISI	22
5.3 ASESMEN GAWAT DARURAT	28
5.4 RENCANA ASUHAN	29
5.5 MENGELOLA ALUR	30
5.6 TATA LAKSANA PASIEN MELARIKAN DIRI	36
BAB VI LOGISTIK	38
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	39
7.1 PENGERTIAN	39
7.2 TUJUAN	39
7.3 STANDAR KESELAMATAN PASIEN	39
7.4 KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)	39
7.5 TATA LAKSANA	40
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	41
8.1 PENGERTIAN	41
8.2 TUJUAN	41
8.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN STAF	41
8.4 PRINSIP KESELAMATAN KERJA	41
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	43
BAB X PENUTUP	44

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 319.30/I-PDM/IGD/IV/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standarisai Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT
DARURAT (IGD).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan



gawat darurat.

- (2) Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam organisasi dan manajemen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Prima Husada.



BAB II SKRINING

Pasal 2

- (1) Skrining di dalam maupun luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan / spesifik untuk menetapkan pasien diterima atau dirujuk;
- (2) Pelaksanaan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- (3) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menangani pasien
- (4) yediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- (5) Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisik, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging;
- (6) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani;
- (7) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien;
- (8) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien;
- (9) Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif.



BAB III TRIASE

Pasal 3

- (1) Kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triase dan tindakan penyelamatan nyawa (life saving);
- (2) Pada setiap pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus dilakukan triase berbasis bukti;
- (3) Triase merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratannya dan prioritas penanganan;
- (4) Setiap staf harus terlatih dalam menggunakan kriteria;
- (5) Prioritas diberikan kepada pasien dengan kebutuhan mendesak.

BAB IV PENUNDAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap harus disampaikan kepada pasien;
- (2) Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien dan dicatat di rekam medis.

BAB V ALUR PASIEN

Pasal 5

- (1) Alur pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Alur pendaftaran pasien rawat inap;
- (3) Alur pendaftaran pasien gawat darurat;
- (4) Alur penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap;
- (5) Alur menahan pasien untuk observasi;
- (6) Alur mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit;
- (7) Proses pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online;
- (8) Pasien gawat darurat tidak ditarik uang muka untuk pelayanan;
- (9) Alur untuk menghindari penumpukan termasuk pada keadaan bencana;
- (10) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien;
- (11) Komponen dari pengelolaan alur pasien meliputi :
 - (a) ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - (b) perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas,



-
- teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
- (c) perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat
 - (d) alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca- anestesi);
 - (e) efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);
 - (f) pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - (g) akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

BAB VI HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

Pasal 6

- (1) Rumah sakit menetapkan tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga;
- (2) Pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga atau pihak lain;
- (3) Semua staf memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga;
- (4) Staf bertanggung jawab melindungi hak pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai- nilai pribadi pasien, serta menghormati dan menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan;
- (2) Rumah sakit menanggapi permintaan rutin termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama dengan memfasilitasi bimbingan kerokhanian di rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengatur tentang kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien;
- (2) Pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pasien harus diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi medis;
- (4) Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi Kesehatan pasien;

- (5) Staf mampu mengidentifikasi dan menghormati harapan dan



kebutuhan privasi saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan, dan transfer pasien.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus dikarenakan kondisi pasien tertentu yang tidak mampu menjaga barang miliknya saat di rumah sakit;
- (2) Staf mampu menjelaskan tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik pasien tersebut kepada pasien.

Pasal 10

Rumah sakit melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan diantaranya ruang bayi, kamar operasi dan kasir (pembayaran).

Pasal 11

- (1) Pasien dan keluarga ikut berpartisipasi dalam proses asuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya;
- (2) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Pasal 12

- (1) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga;
- (2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti;
- (3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4) Pasien dijelaskan bila ada tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan proses memberikan persetujuan;
- (5) Pasien dijelaskan hasil yang diharapkan maupun kemungkinan hasil tidak terduga dari proses asuhan dan pengobatan;
- (6) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan;

Pasal 13

- (1) Rumah sakit mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA;
- (2) Pasien dijelaskan diagnosis, kondisi pasien, tindakan yang diusulkan, tata cara dan tujuan tindakan, manfaat dan risiko tindakan, DPJP pelaksana tindakan, kemungkinan alternatif dari tindakan, prognosis, kemungkinan hasil yang tidak terduga serta



kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan

- (3) DPJP, PPJA, dan PPA harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien.

Pasal 14

- (1) Pasien serta keluarganya berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan;
- (2) Pasien dan keluarga dijelaskan konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan tersebut;
- (3) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Pasal 15

Rumah sakit menetapkan peraturan pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat.

BAB VII

TRANSFER INTRAHOSPITAL

Pasal 16

- (1) Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien;
- (2) Form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat;
- (3) Form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostic;
- (4) Form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat;
- (5) Form tersebut memuat setiap prosedur yang dilakukan;
- (6) Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan;
- (7) Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer);
- (8) Ketentuan tersebut dilaksanakan.

BAB VIII

RUJUKAN

Pasal 17

- (1) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - (a) diagnosis dan teramelaipi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - (b) alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - (c) risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;



- (d) transportasi rujukan;
- (e) risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 18

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah:

- (1) melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (2) melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
- (3) membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat :

- (1) identitas pasien;
- (2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- (3) diagnosis kerja;
- (4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- (5) tujuan rujukan;
- (6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien;
- (2) Selama proses transportasi rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- (3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

Pasal 21

Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 sampai pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA MALANG
NOMOR : 319.30/I-PDM/IGD/IV/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
GAWAT DARURAT

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Pasien yang masuk ke IGD Rumah Sakit Prima Husada tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan response time yang cepat dan penanganan yang tepat.

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai dengan standar.

Untuk itu rumah sakit prima husada harus dapat menyusun perencanaan di bidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat yang baik dan terarah agar mutu pelayanan kesehatan tidak menurun, sebaliknya meningkat dengan pesat. Oleh karenanya Depkes perlu membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi acuan bagi rumah sakit prima husada dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di Instalasi Gawat Darurat RS.

1.2 TUJUAN PEDOMAN

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan dengan mutu tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien
2. Pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan dapat berjalan dengan baik berdasarkan SPO sehingga keselamatan pasien dapat dimaksimalkan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dengan pengutamaan pada upaya preventif dan kuratif.
4. Menciptakan instalasi rawat jalan dengan pelayanan yang nyaman dan lingkungan yang aman.

1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Diagnosis & penanganan permasalahan pada :
 - A : Jalan nafas (airway problem)
 - B : Pernafasan (Breathing problem) dan
 - C : Sirkulasi pembuluh darah (Circulation problem)
2. Penilaian Disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU)
3. Bedah cito

1.4 BATASAN OPERASIONAL

1. Gawat Darurat

adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

2. Pelayanan Gawat Darurat
adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3. Korban/Pasien Gawat Darurat
adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
4. *Triage*
Adalah pengelompokan pasien yang berdasarkan atas berat ringannya trauma / penyakit serta kecepatan penanganan / pemindahannya.
5. Prioritas
Adalah penentuan mana yang harus didahulukan mengenai penanganan dan pemindahan yang mengacu tingkat ancaman jiwa yang timbul.
6. *Survey Primer*
Adalah deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa.
7. *Survey Sekunder*
Adalah melengkapi survei primer dengan mencari perubahan – perubahan anatomi yang akan berkembang menjadi semakin parah dan memperberat perubahan fungsi vital yang ada berakhir dengan mengancam jiwa bila tidak segera diatasi.
8. Pasien Gawat darurat
Adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
9. Pasien Gawat Tidak Darurat
Adalah pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat misalnya kanker stadium lanjut
10. Pasien Darurat Tidak Gawat
Adalah pasien akibat musibah yang datang tiba – tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya, misalnya luka sayat dangkal.
11. Pasien Tidak Gawat Tidak Darurat
Adalah pasien yang tidak berada dalam keadaan gawat tidak memerlukan tindakan darurat atau tidak mengancam nyawa dan anggota badannya (akan menjadi cacat) Misalnya pasien dengan batuk pilek , TBC kulit , dan sebagainya
12. Kecelakaan (*Accident*)
Adalah suatu kejadian dimana terjadi interaksi berbagai faktor yang datangnya mendadak, tidak dikehendaki sehingga menimbulkan cedera fisik, mental dan sosial.
13. Cidera
Adalah masalah kesehatan yang didapat / dialami sebagai akibat kecelakaan.
14. Bencana
Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan.

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SDM

Sesuai dengan kemenkes 856 tahun 2009 tentang standard igd rs prima husada (tipe C) adalah level 2,

Pola ketenagaan dan kualifikasi SDM IGD adalah :

No.	Jabatan	Kualifikasi Tenaga	Waktu Kerja
1	Dokter spesialis	Bedah, obsgyn, anak, penyakit dalam	On call
2	Dokter umum	Pelatihan kegawat daruratan, GELTS, ATLS, ACLS, dll	On site 24 jam
3	KARU	Pelatihan kegawat daruratan, emergency nursing, BTLS, BCLS dll	Jam kerja
4	Perawat pelaksana	Pelatihan emergency nursing	On site 24 jam
5	Non medis	APAR	On site 24 jam

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Pake tabel berapa shift dokternya

No	Nama Jabatan	Jabatan	Jumlah
1	dr Ardhi Bustami, Sp.PD	Dokter Penyakit dalam	1
2	dr Heriatmo Sadi, Sp.PD	Dokter Penyakit dalam	1
3	dr Antonius Setiadi, Sp.B	Dokter Bedah	1
4	dr Andi Abdillah, Sp.B	Dokter Bedah	1
5	dr Aida Musyarofah, Sp.Og	Dokter Obgin	1
6	dr Humairah Rahma, Sp.Og	Dokter Obgin	1
7	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A	Dokter anak	1
8	dr. Fiona, Sp.A	Dokter anak	1
9	dr. Adhya Aji P, Sp.PD	Kepala Instalasi IGD	1
10	Ns. Afni Nur Ainy, S.Kep.,	KARU IGD	1
11	dr. Rino Rahmatullah	Dokter IGD	1
12	dr. Andira Aulia Rahma	Dokter IGD	1
13	dr Yuniar Ardhy Santoso	Dokter IGD	1
14	dr. Yeni Octavia	Dokter IGD	1
15	dr. Isrotul Anisa	Dokter IGD	1
16	dr. Annishafira Widyawardani	Dokter IGD	1
17	dr. Gusti Gandha	Dokter IGD	1
18	Ns. Beny Wahyudi, S.Kep.,	PJ Shift	1
19	Ns Fariz Tiarawan, S.Kep	PJ Shift	1

20	Rizal Ari Wicaksono, AMd. Kep	PJ Shift	1
21	Lita Oktavian, AMd. Kep	PJ Shift	1
22	Noor Rachmad, STr,Kep	PJ Shift	1
23	Kholilul Rohman, AMd. Kep	PJ Shift	1
24	Ns. Bagus Ardhiansyah Putra, S.Kep	Perawat pelaksana	1
25	Ns. Roida Saputri, AMd.Kep	Perawat pelaksana	1
26	Zahrocha Fathmanda R, AMd. Kep	Perawat pelaksana	1
27	Ns. Fakhrur Rifqi A, S.Kep	Perawat pelaksana	1
28	Nungky Putri P, AMd. Kep	Perawat pelaksana	1
29	Ns. Rani Karisma R, S.Kep	Perawat pelaksana	1
30	Lovely Aulia Edy, AMd. Kep	Perawat pelaksana	1
31	Ns. Rizki Esa Wisnu W, S.Kep	Perawat pelaksana	1
32	Tiara Anggita P, STr.Kep	Perawat pelaksana	1
33	Ns. Shynta Dinar Audia, S.Kep	Perawat pelaksana	1
34	Alfia Indrawati, AMd. Kep	Perawat pelaksana	1

2.3 PENGATURAN JAGA

Dengan tenaga sumber daya manusia IGD membagi pengaturan jadwal dinas sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi waktu	Jumlah SDM
1	Ka Instalasi IGD	1 Sif	06.30 – 14.30	1
2	Dokter Spesialis	1 Sif	06.30 – 14.30	1
3	Karu IGD	1 Sif	08.00 – 16.00	1
4	Dokter IGD	Pagi Sore Malam	06.30 – 14.30 14.00 – 22.00 22.00 – 06.30	7
5	Perawat Pelaksana	Pagi Sore Malam	06.30 – 14.30 14.00 – 22.00 22.00 – 06.30	17
6	Cleaning Service	Pagi Sore Malam	06.30 – 14.30 14.00 – 22.00 22.00 – 06.00	3

BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANGAN
(Ada pada lampiran)

3.2 STANDAR FASILITAS

- a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / bencana.
- b. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Rumah Sakit.
- c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar).
- d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp).
- e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
- f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS).
- g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga.
- h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD
- i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
- j. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
- k. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD.
- l. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

3.3 PERSYARATAN SARANA

No.	Kelas/Ruang	Persyaratan Ruangan	Keterangan
1.	RUANG PENERIMAAN	a. R. Tunggu (Public Area) - Informasi - Toilet	
		b. R. Administrasi - Pendaftaran pasien baru/rawat - Rekam medis	- Tergantung IT system
		c. R. Triase	
		d. R. penyimpanan strecher	
		e. R. informasi dan komunikasi	
2	RUANG TINDAKAN	a. R. Resusitasi	
		b. R. tindakan : - Bedah - Non Bedah/ medical - Anak dan kebidanan	- Bisa bergabung
		c. R. Dekontaminasi	- Bagi IGD yang berada dekat industry harus

			memiliki ruang ini
3.	RUANG OPERASI	Ruang IKO	- Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam
4.	RUANG OBSERVASI	Ruang observasi	
5.	RUANG KHUSUS	a. R. Intermediate/ HCU - Umum	- Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam

3.4 PRASARANA MEDIS

Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh level IGD rumah sakit, juga oleh jumlah kasus yang ditangani.

NO.	KELAS / RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN
1.	A. RUANG TRIASE	Kit Pemeriksaan sederhana	Minimal 2
		Brankar Penerimaan Pasien	Rasio (Cross Sectional)
		Pembuatan rekam medik khusus	(Perlu dibuatkan form)
		Label (pada saat korban missal)	
	B. RUANG TINDAKAN RUANG RESUSITASI	Nasopharingeal tube	Minimal 1 setiap no
		Oropharingeal tube	Minimal 1 setiap no
		Laringoscope set anak	Minimal 1 setiap no
		Laryngoscope set dewasa	Minimal 1 setiap no
		Nasotrakheal tube	Minimal 1 setiap no
		Orotracheal	Minimal 1 setiap no
		Suction	Minimal 1 setiap no
		Tracheostomi set	Minimal 1 setiap no
		Bag Valve Mask (Dewasa/ anak)	Minimal 1 setiap no
		Kanul oksigen	Sesuai jumlah IT
		Oksigen Mask (Dewasa/ Anak)	Minimal 1
		Chest Tube	Minimal 1
		Crico /Trakheostomi	Minimal 1
		Ventilator, Transport	Minimal 1
		Vital Sign Monitor	Sesuai Jumlah TT
		Infusion Pump	2 s/d 3 tiap TT
		Syringe	
		ECG	Minimal 1
		Vena Section	Minimal 1
		Defibrillator	Minimal 1
		Gluko stick	Minimal 1

		Stetoskop	Minimal 1
		Thermometer	Minimal 1
		Nebulizer	Minimal 1
		Oksigen Medis/ Concentrators	Rasio 1 : 1 TT di IGD
		Warmer	Minimal 1
		Immobilization Set	
		Neck Collar	Minimal 1
		Splint	Minimal 1 set
		Long spine board	Minimal 1 set
		Scoop stretcher	Minimal 1 set
		Kendrik Extrication Devive (KED)	Minimal1 set
		Urine Bag	Minimal 1 set/ TT
		NGT	Minimal 1 set
		Wound Toilet Set	Minimal 1 set

NO.	KELAS / RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN
		Kendrik Extrication Devive (KED)	Minimal 1 set
		Urine Bag	Minimal 1 set/ TT
		NGT	Minimal 1 set
		Wound Toilet Set	Minimal 1 set
OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI			
		Cairan infus Koloid	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan
		Cairan infus Kristaloid	
		Cairan infus Dextrose	
		Adrenalin	
		Sulfat Atropin	
		Kortikosteroid	
		Lidokain	
		Dextrose 50 %	
		Aminophilin	
		ATS,TT	
		Trombolitik	
		Amiodaron (inotropik)	
		APD : masker, sarung tangan, kaca mata google	
		Manitol	
		Furosemide	
2.	RUANG TINDAKAN BEDAH		
ALAT MEDIS			
		Meja Operasi/ Tempat tidur Tindakan	Minimal 1
		Dressing set	Minimal 1
		Infusion set	Minimal 1
		Vena section set	Minimal 1
		Torakosintesis set	Minimal 1
		Metal kauter	Minimal 1

		Film viewer	Minimal 1
		Tiang infuse	Minimal 1
		Lampu operasi	Minimal 1
		Thermometer	Minimal 1
		Stetoskop	Minimal 1
		Suction	Minimal 1
		Sterilisator	Minimal 1
		Bidai	Minimal 1
		Splint	Minimal 1

NO.	KELAS / RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN
OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI			
		Analgetik	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan
		Antiseptik	
		Cairan kristaloid	
		Lidokain	
		Wound dressing	
		Alat-alat anti septic	
		ATS	
		Anti Bisa Ular	
		Anti Rabies	
		Benang jarum	
		APD : masker, sarung tangan, kaca mata google	
3.	RUANG TINDAKAN MEDIK		
		Kumbah Lambung Set	Minimal 1
		EKG	Minimal 1
		Kursi Periksa	Minimal 1
		Irigator Pemeriksaan	Minimal 1
		Nebulizer	Minimal 1
		Suction	Minimal 1
		Oksigen Medis	Minimal 1
		NGT	Minimal 1
		Syringe Pump	Minimal 2
		Infusion Pump	Minimal 2
		Jarum spinal	Minimal 1
		Lampu Kepala	Minimal 1
		Otoscope set	Minimal 1
		Slit Lamp	Minimal 1
		Tiang Infus	Minimal 1
		Tempat Tidur	Minimal 1
		Film Viewer	Minimal 1
OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI			
		Cairan Infus Koloid	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan.
		Cairan Infus Kristaloid	
		Cairan Infus Dextrose	
		Adrenalin	
		Sulphas Atropin	

		Kortikosteroid	
		Lidocain	
		Aminophilin	
		Pethidin	
		Morfin	
		Anti convulsion	
		Dopamine	

NO.	KELAS / RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN
		Dobutamin	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan
		ATS	
		Trombolitik	
		Amiodaron (inotropik)	
		APD : masker, sarung tangan, kaca google	
		Manitol	
		Furosemide	
4.	RUANG TINDAKAN BAYI DAN ANAK		
PERALATAN MEDIS			
		Inkubator	Minimal 1
		Tiang Infus	Minimal 1
		Tempat Tidur	Minimal 1
		Film Viewer	Minimal 1
		Suction	Minimal 1
		Oksigen	Minimal 1
OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI			
		Stesolid	Tersedia dalam jumlah yang cukup
		Mikro drip set	
		Intra Osseus set	
5.	RUANG TINDAKAN KEBIDANAN		
		Kuret Set	Minimal 1/ bergabung
		Partus Set	Minimal 1/ bergabung
		Suction bayi	Minimal 1/ bergabung
		Meja Ginekologi	Minimal 1/ bergabung
		Meja Partus	Minimal 1/ bergabung
		Vacuum set	Minimal 1/ bergabung
		Forcef	Minimal 1/ bergabung
		CTG	Minimal 1/ bergabung
		Resusitasi set	Minimal 1/ bergabung
		Doppler	Minimal 1/ bergabung
		Suction Bayi baru lahir	Minimal 1/ bergabung
		Laennec	Minimal 1/ bergabung
		Tiang Infus	Minimal 1/ bergabung

		Tempat Tidur	Minimal 1/ bergabung
		Film Viewer	Minimal 1/ bergabung

NO.	KELAS / RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN
OBAT – OBATAN			
		Uterotonika	Tersedia dalam jumlah yang cukup
		Prostaglandin	
6.	RUANG OPERASI (R. PERSIAPAN DAN KAMAR OPERASI)		
	A. RUANG PERSIAPAN		
		Ruang ganti	Tindakan / operasi yang dilakukan terutama untuk keadaan Cito, bukan elektif
		Brankar	
		Oksigen	
		Suction	
		Linen	
	B. KAMAR OPERASI		
	Meja operasi	Minimal 1	Tindakan yang dilakukan terutama untuk kedaan Cito, bukan elektif
	Mesin Anastesi	Minimal 1	
	Alat regional Anestesi	Minimal 1	
	Lampu (mobile/ statis)	Minimal 1	
	Pulse Oximeter	Minimal 1	
	Vital Sign Monitor	Minimal 1	
	Meja Istrumen	Minimal 1	
	Suction	Minimal 1	
	Suction	Minimal 1	
	Film viewer	Minimal 1	
	Set Bedah dasar	Minimal 1	
	Set laparatomi	Minimal 1	
	Set Apendiktomi	Minimal 1	
	Laringoscopi	Minimal 1	
	Bag Valve Mask	Minimal 1	
	Defibrillator	Minimal 1	
	C. RUANG RECOVERY		
	Infusion pump	Minimal 2	Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan cito, bukan elektif.
	Syringe pump	Minimal 2	
	Bed Side Monitor	Minimal 1	
	Tiang Infus	Minimal 1	
	Infusion set	Minimal 1	
	Oxygen Line	Minimal 1	
	D. RUANG PENUNJANG MEDIS		
	Mobile X-ray	Minimal 1	Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam
	Apron Timbal	Minimal 2	
	Automatic Film	Minimal 1	
NO.	KELAS/RUANG	PERSYARATAN PRASARANA MEDIS	KETERANGAN

	Film viwer	Minimal 1	Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam
5.	RUANG LABORATORIUM		
	A. LAB STANDAR		
	Lab. Rutin	+	Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam
	Elektrolit	+	
	Kimia Darah	+	
	Analisa Gas Darah	+	
	B. LAB KHUSUS		
	Bank Darah (BDRS)	Bisa bergabung	Dapat diakses 24 jam
	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)		
6.	RUANG STERILISASI		
	Basah	Minimal 1	Minimal 1
	Autoclave	Minimal 1	Minimal 1
7.	GAS MEDIS N2O		
	Tabung Gas		
	Sentral		
	C. RUANG PENUNJANG NON MEDIS		
	1. ALAT KOMUNIKASI INTERNAL		
	Fix	+	
	Mobile	+	
	Radio Medik	+	
	2. ALAT KOMUNIKASI EKSTERNAL		
	Fix	+	
	Mobile	+	
	Radio Medik	+	
	3. ALAT RUMAH TANGGA		
	Tersedia		
	Komputer	+	
	Mesin Ketik	+	
	Alat Kantor	+	
	Meubelair	+	
	Papan Tulis	+	

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 PELAYANAN RAWAT INAP YANG BISA DILAKUKAN DI RSPH

KURATIF	REHABILITATIF	PALIATIF
TF, DF, TBC, HIPERTENSI, GEA,	CVA trombosis	CKD tanpa HD
Appendix, Hernia, Hemoroid,	Fraktur Tulang tanpa komplikasi	KANKER tanpa Khemoteraphi

4.2 PELAYANAN RAWAT INAP YANG TIDAK BISA DILAKUKAN DI RSPH

Jenis penyakit		
HIV / AIDS	Pro pengobatan ARV	Rujuk RS tipe A, MOU dengan RS Saiful Anwar Malang
Penyakit Jantung Bawaan	Pro operasi	
STEMI	Pro Revascularisasi	
DVT	Pro operasi	
Kanker	Pro khemotherapi	
Fr.Thoraco lumbal	Pro operasi	
CKD	Pro HD	
Gangguan Jiwa dengan gaduh Gelisah	Pro ruang perawatan pasie jiwa	
Thalasemia	Pro transplantasi sumsum tulang belakang	

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 SKRINING PASIEN

Rumah Sakit menetapkan proses skrining baik pasien rawat inap maupun rawat jalan untuk mengidentifikasi pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit.

- 1) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit.
- 2) Skrining dilaksanakan melalui kriteria triage, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisik, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging.
- 3) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani.
- 4) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan sesuai yang dibutuhkan pasien.
- 5) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien.
- 6) Skrining khusus dapat dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai kebutuhan seperti skrining nyeri, skrining geriatri, skrining jatuh, skrining Infeksi (TBC, Covid 19, Pinere) atau skrining lainnya.
- 7) Skrining Pasien di Rumah Sakit dilakukan oleh staf medis, staf keperawatan dan staf kebidanan yang berkompeten.

Proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan/ spesifik untuk menetapkan apakah pasien diterima atau dirujuk.

Petugas Instalasi Gawat Darurat harus dapat menyeleksi pasien sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien untuk kemudian memilah pasien berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup pelayanan pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya meliputi :

Pasien dengan kasus *emergency*, yaitu pasien yang berada dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan bisa menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan yang tepat secepatnya.
- b. Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat.
- c. Pasien akibat musibah/kejadian yang tiba-tiba terjadi, tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya.

Dengan demikian keberhasilan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dalam mencegah kematian dan cacat ditentukan oleh:

1. Kecepatan menemukan penderita gawat darurat
2. Kecepatan meminta pertolongan
3. Kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan:
 - a. Di tempat kejadian
 - b. Dalam perjalanan ke rumah sakit
 - c. Pertolongan selanjutnya secara mantap dirumah sakit

Skrining Pasien Dengan keterbatasan Fisik :

- 1) Macam-Macam / Jenis-Jenis Kecacatan atau Kelainan Pada Manusia :
 Buta (Tuna Netra)
 Pasien buta adalah pasien yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Pasien yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.
- 2) Tuli (Tuna Rungu)
 Pasien tuli adalah Pasien yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana Pasien normal pada umumnya. Pasien yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.
- 3) Bisu (Tuna Wicara)
 Pasien bisu adalah Pasien yang tidak bisa berbicara dengan Pasien lain. Pasien yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Pasien bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.
- 4) Cacat Fisik (Tuna Daksa)
 Pasien yang tuna daksa adalah Pasien yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.
- 5) Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)
 Pasien yang tuna grahita adalah Pasien yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)
 Pasien yang tuna laras adalah Pasien yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu Pasien yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.
- 7) Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)
 d. Pasien yang tuna ganda adalah Pasien yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti Pasien yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau Pasien yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT PADA PASIEN RAWAT JALAN :

N O	Diagnosa /Penanganan	Pemeriksaan	Tindakan	Lanjutan
1.	Demam	Darah Lengkap, widal Urine Lengkap.(Pilih Salah 2)	-	Obat pulang
2	Colic Abdomen	USG (Dokter bersertifikat atau dokter radiologi dikunjungi jadi satu kali kunjungan)	USG	Obat Pulang

3	Chest Pain, UAP, Angina Pectoris, IMA	ECG	-	Obat Pulang
4.	Luka tusuk Pemberian ATS (Anti Tetanus Serum)	-	Cross incisi	Obat Pulang
5.	Dislokasi/Fraktur/ Sprain / Strain Injury	Foto Extremitas Atas Dan Bawah (Pilih satu Foto)	Reposisi / Close Redution □Tensocrepe	Obat Pulang
6.	Full up(< 10 Cm) /vulnus apertum bagian extremitas atas/bawah	Foto Exstermitas atas dan bawah (Pilih Satu Foto)	a.Repair of skin (Heacting)	Obat Pulang
7.	Trauma Thorax, Spain, Strain	Thorax	Debridement	Obat Pulang
8.	CKR	Foto Skull AP	Debridement	Obat Pulang
9.	Gram mata, trauma okuli, insect bite pada mata	-	Removal subconjungtiva/subcorneal	Obat pulang
10	Hemorrhoid ex/in	-	Reduction hemoroid	Obat pulang
11	COPD, Bronkitis, Asma (Dx Paru atau Jantung)	-	Nebulazer	Obat Pulang
12	Avulsi nail	-	Ekstraksi Kuku	Obat Pulang
13	Benda asing telinga ,Forumen		Ekstraksi benda asing	Obat Pulang
14	Benda asing hidung		Ekstraksi Benda asing	Obat Pulang
15	Benda asing tenggorokan	-	Ekstraksi Benda Asing	Obat Pulang
16	BPH(Dx Urologi yg lainnya)	-	Pasang chateter	Obat pulang
17	Post Heacting		Debridement	Obat Pulang
18	Fractur Cervical	Foto Cervical	Pemasangan Cervical Cooler : (Prosedur LUPIS)	Obat Pulang

SKRINING PASIEN IGD

NO	Diagnosi s	TRIAGE	HASIL PEMERIKSAAN FISIK	PSIKO LOGIS	LAB KLINIS	DIAGNOSIS IMAGING	Kriteria dirawat	Kriteria dirujuk
	HIV/AIDS	Visual : pasien tampak kurus khas pasien HIV	1. Anamnesis : Demam menggigil , lemah badan, berat badan menurun, keringat malam,ruam kulit, sariawan pada mulut atau kelamin, diare berkepanjangan, infeksi herpes pada mulut, genital, anus 2. Pemeriksaan Fisik Tax : < 36 atau > 39 BB □ menurun Mata □ rinitis Mulut □ infeksi jamur Perut □ splenomegali, hepatomegali Kulit□ ruam, dermatitis seboroik Ginekologi □	Denial Depression Anger Bargaining Anxiety acceptance	Darah Lengka p: Lekosit openia Rapid test Ellisa Wester n blood	Thorax PA Tampak	Tidak memerl ukan pengob atan arv. Ruang perawat an :	Memerlukan pengobatan arv . RS rujukan dg poli VCT : 1. RS tipe A 2.

	Cedera otak berat	Penurunan kesadaran	● GCS 3-8 : Cedera kepala berat : Cedera multipel. + perdarahan intrakranial dg GCS ringan /sedang. ● Battle sign (warna biru/ekhimosis dibelakang telinga di atas os mastoid) ● Hemotimpanum (perdarahan di daerah gendang telinga) ● Periorbital ecchymosis (mata warna hitam tanpa trauma langsung) ● Rhinorrhoe (liquor keluar dari hidung) ● Otorrhoe (liquor keluar dari telinga)	(-)	DL Hb : anemia	Skull Thorax Ct scan	Perbaikan k.u	Pro trepanasi : Stabilisasi pasien □ rujuk RS rujukan dengan Sp. BS :
	CKD stadium 5 pro HD	Lemah letih Pucat	Anamnesis ; Lemah letih , Sesak nafas Edema ekstermitas Px fisik : Pucat, sesak edema tungkai		DL UI Ureum Creatinin Elektrolit albumin LFG	Usg abdomen	Perbaikan ku.	Pro Hd RS rujukan: 1.RS TIPE A

	Gangguan jiwa dengan gaduh gelisah	Gaduh gelisah Menangis Euforia Agresif Ketakutan	Anamnesis Gangguan pola pikir Depersonalisasi, depresi , obsesi kompulsi, disosiasi konversi cemas Pmx fisik dalam batas normal	-	-	-	Tidak bisa dirawat	Pro rujuk ke rs jiwa
	)							
	Kecelakaan massal (proses penyaringan)	Visual : luka ringan hingga luka berat Cedera kepala ringan hingga cedera kepala berat	Triage hijau : kondisi stabil bisa diajak berkomunikasi luka ringan Triage Kuning : kondisi lemah tetapi tdk ada keadaan yg mengancam Triage Merah : penurunan kesadaran Triage hitam : perawatan jenazah		DL, GDA UL	Skull ap lat Thorax	Triage hijau : kondisi stabil bisa diajak berkomunikasi bisa diajak berkomunikasi perbaikan kondisi di rs Triage Kuning : kondisi lemah tetapi tdk ada keadaan yg mengancam perbaikan kondisi di rs Triage Merah : penurunan kesadaran perbaikan kondisi dan pro rujuk Triage hitam : perawatan jenazah	

							n kondisi di rs Triage Merah : penurun an kesadar an perbaika n kondisi dan pro rujuk Triage hitam : perawat an jenasah	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

	ACS	Visual : tampak nyeri khas yaitu seperti ditekan atau terasa berat di dada yang sering menjalar ke lengan kiri.	Anamnesis : nyeri khas yaitu seperti ditekan atau terasa berat di dada yang sering menjalar ke lengan kiri , kedua tangan atau dagu Pmx fisik : keringat dingin Hipotensi atau hipertensi Tanda syok kardiogenik		DL, OT PT GDA UR CR,UL CKMB TROP ONIN LIPID PROFI L,	ECG THORAX	Perbaikan k.u	Rujuk ke rs dengan fasilitas pci
--	-----	--	---	--	--	---------------	---------------	----------------------------------

5.2 ADMISI

Penentuan pasien rawat inap akan sangat terbantu dari hasil skrining yang baik untuk mengidentifikasi pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif yang dibutuhkan pasien kemudian menentukan pelayanan yang paling sesuai dan mendesak atau yang paling diprioritaskan

Rumah sakit telah menetapkan kriteria prioritas untuk menentukan pasien yang membutuhkan pelayanan di unit khusus / spesialisik atau pelayanan di unit intensif (ICU, NICU, pascaoperasi)

Pasien yang diterima di unit tersebut harus dilakukan pengkajian ulang untuk menentukan apakah kondisi pasien berubah sehingga tidak memerlukan lagi pelayanan khusus / intensif

a. PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN IGD

Proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran pasien rawat jalan. Proses tersebut meliputi

a. Pendaftaran pasien rawat jalan

Tatalaksana Pendaftaran rawat jalan dapat dilakukan melalui 3 cara :

1. WA pada nomor yang dituju dengan format pengisian :

*PASIEN BARU

- a. Jenis Pembayaran (UMUM/BPJS/Asuransi)
- b. Nama Lengkap
- c. Jenis Kelamin (Laki-Laki/Perempuan)
- d. Tempat lahir
- e. Tanggal lahir
- f. Alamat lengkap
- g. NIK
- h. No Telp dan E-mail
- i. Nama ibu kandung
- j. Klinik Tujuan
- k. Tanggal kunjungan/control
- l. Dokter

*PASIEN LAMA

- a. Jenis pembayaran (UMUM/BPJS/Asuransi)
- b. Nomor rekam medis
- c. Nama lengkap
- d. Klinik tujuan
- e. Dokter
- f. Tanggal kunjungan/kontrol

2. Online dengan mengunjungi website : www.rs-primahusada.com

3. Telepon dengan menghubungi nomer RS yang tercantum, dengan menyebut ; jenis pasien, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, poli tujuan, jenis pembayaran, tanggal kontrol yang dikehendaki

b. Penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawat inap

c. Menahan pasien untuk observasi

Menahan pasien untuk observasi adalah menahan pasien yang membutuhkan observasi karena kondisi belum jelas atau masih menunggu hasil pemeriksaan :

1. Perawat Memberikan penjelasan pada pasien dan keluarga terkait kondisi pasien yang masih perlu observasi
2. Observasi dikerjakan maksimal 6 jam di IGD dari jam kedatangan
Setiap pasien observasi Mintakan persetujuan dan tandatangan pasien dan atau keluarga pasien
3. Melakukan instruksi sesuai advis dokter
4. Mencatat dilembar observasi
5. Perawat melaporkan ke dr IGD jika pasien sudah stabil
6. Dokter bisa menentukan pasien layak transfer atau tidak

b. PELAYANAN GAWAT DARURAT

i. TATA LAKSANA PENGISIAN *INFORMED CONSENT*

1. Petugas Penanggung Jawab
 - Dokter jaga IGD
2. Perangkat Kerja
 - Formulir Persetujuan Tindakan
3. Tata Laksana Informed Consent
 - a. Dokter IGD yang sedang bertugas menjelaskan tujuan dari pengisian informed consent pada pasien / keluarga pasien (SPO – IGD) disaksikan oleh perawat
 - b. pasien menyetujui, informed consent diisi dengan lengkap disaksikan oleh perawat.
Setelah diisi dimasukkan dalam status medik pasien

c. PENUNDAAN DAN KETERLAMBATAN PELAYANAN

Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Penundaan pelayanan yang dapat terjadi di Rumah Sakit Prima Husada antara lain:

1. Pemeriksaan test alergi di rawat jalan.
Penyebab : keterbatasan penggunaan reagen
2. Pemeriksaan MRI
Penyebab : MRI dilakukan di Rumah Sakit rujukan, karena Rumah Sakit Prima Husada belum memiliki MRI

Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dicatat di rekam medis.

d. PENGELOLAAN ALUR IGD

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien.

Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien. Komponen dari pengelolaan alur pasien termasuk :

- a. Ketersediaan tempat tidur rawat inap :
Ketersediaan tempat tidur rawat inap tersedia dilayar monitor yang ada di depan IGD Rumah Sakt Prima Huasada meliputi
 1. TT yang tersedia beserta kelas
 2. TT yang terpakai dan tt yg blm terpakai
- b. Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien dapat disediakan dilorong irna lantai 1 dan lantai 2 gedung B, dimana dilengkapi dengan peralatan sebai berikut :
 1. Bed pasien
 2. Standart infus
 3. Oksigen tranport

- c. Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat dilakukan perbantuan tenaga yang disuplay dari unit lain atas persetujuan kepala ruang.
- d. Alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca anestesi).
- e. Efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi) dilakukan oleh petugas Helper dengan prioritas membantu instalasi gawat darurat.
- f. Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien diberikan berdasarkan proedur yang diterapkan di Rumah Sakit Prima Husada antara lain:
Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/Case Manager.

Alur pasien menuju dan penempatannya di unit gawat darurat berpotensi membuat pasien bertumpuk. Ada penempatan pasien di unit gawat darurat yang merupakan jalan keluar sementara mengatasi penumpukan pasien rawat inap rumah sakit.

Dengan demikian, rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien di unit darurat dan di unit intermediate, kemudian harus ditransfer ke unit rawat inap rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan yang aman bagi pasien.

e. TRIAGE

Pasien darurat, sangat mendesak, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada kondisi bencana dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak, dan membutuhkan pertolongan segera maka dilakukan asesmen dan menerima pelayanan secepat-cepatnya. Kriteria psikologis dibutuhkan dalam proses triase. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan pelayanan yang dibutuhkan.

Jika rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan kondisi darurat, pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang fasilitas pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan pasien. Sebelum ditransfer atau dirujuk pasien harus dalam keadaan stabil *dan dilengkapi dengan dokumen pencatatan*.

Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa. Tujuan *triage* selanjutnya adalah untuk menetapkan tingkat atau derajat kegawatan yang memerlukan pertolongan kedaruratan.

Dengan *triage* tenaga kesehatan akan mampu :

1. Menginisiasi atau melakukan intervensi yang cepat dan tepat kepada pasien
2. Menetapkan area yang paling tepat untuk dapat melaksanakan pengobatan lanjutan
3. Memfasilitasi alur pasien melalui unit gawat darurat dalam proses penanggulangan/pengobatan gawat darurat

Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat diseleksi berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya dengan menggunakan *Australian Triage Scale* (ATS) sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	KATEGORI I	KATEGORI II	KATEGORI III	KATEGORI IV	KATEGORI V
JALAN NAFAS	Sumbatan ☐	Bebas ☐	Bebas ☐	Bebas ☐	Bebas ☐
PERNAPASAN	Henti nafas ☐ Frek Napas < 10x/ mnt ☐ Sianosis ☐	Frek Nafas ☐ > 32 x/mnt Mengi	Frek nafas ☐ >24-32 x/mnt Mengi	Frek Nafas ☐ 20-24 x/ mnt	Frek Nafas ☐ 16-20 x/Menit
SIRKULASI	Henti Jantung ☐ Nadi tidak Teraba ☐ Pucat ☐ Akral Dingin ☐	Nadi teraba lemah ☐ Frek nadi ☐ < 50x/mnt atau >150 x/mnt Pucat ☐ Akral dingin CRT <2 ☐	Frek Nadi ☐ 120-150 x/mnt TD Sistol ☐ >160 mmHg TD diastol ☐ >100 mmHg	Frek Nadi ☐ 100-120 x/mnt TD sistol ☐ ≥120-140 mmHg TD diastol ☐ ≥80 - 100 mmHg	Frek Nadi ☐ 80-100 x/mnt TD sistol ☐ 120 mmHg TD diastol ☐ 80 mmHg
KESADARAN	GCS < 9	GCS 9 – 12	GCS > 12	GCS 15	GCS 15
RESPON TIME	Immediate	<10 Menit	30 Menit	60 Menit	120 Menit

Adapun berikut ini adalah berbagai kondisi yang dapat dikategorikan termasuk sebagai kasus *emergency*, antara lain :

1. **ATS 1 :**
 - a. Henti Jantung
 - b. Henti Napas
 - c. Risiko sumbatan jalan napas
 - d. Frekuensi pernapasan (RR) < 10x/menit
 - e. *Distress* / Kesukaran pernapasan yang sangat berat (*extreme*)
 - f. Tekanan darah < 80 (dewasa) atau syok pada anak/bayi
 - g. Tidak respon atau hanya respon nyeri (GCS < 9)
 - h. Kejang terus menerus atau berkepanjangan
 - i. Overdosis IV dan tidak responsif atau hipoventilasi
 - j. Gangguan perilaku berat dengan ancaman segera terhadap kekerasan yang berbahaya.

2. **ATS 2 :**
 - a. Risiko Jalan Napas – Stridor berat atau produksi air liur berlebih yang membahayakan
 - b. *Distress* / kesukaran pernapasan berat
 - c. Gangguan Sirkulasi :
 - Kulit berkeringat atau berubah warna karena perfusi yang buruk
 - Detak jantung < 50 atau > 150 (dewasa)
 - Hipotensi dengan gangguan hemodinamik
 - Kehilangan darah hebat
 - Nyeri dada kardiak

- d. Nyeri sangat hebat – apapun penyebabnya
- e. Kadar Gula Darah < 2 mmol/l
- f. Mengantuk, penurunan respon (GCS < 13)
- g. Hemiparesis / disfasia akut
- h. Demam dengan tanda-tanda letargi (semua umur)
- i. Terkena zat asam atau basa pada mata – membutuhkan irigasi
- j. Multitrauma mayor (membutuhkan respon cepat dari tim terorganisasi)
- k. Trauma lokal berat – Fraktur mayor, amputasi
- l. Riwayat penyakit risiko tinggi
- m. Konsumsi obat penenang atau zat toksik lainnya secara signifikan
- n. *Envenomation* (tergigit hewan beracun) yang signifikan / berbahaya
- o. Nyeri hebat yang memberi kesan adanya Pre eklampsia, AAA (*Abdominal Aortic Aneurysm*) / Aneurisma Aorta Abdominalis, atau Kehamilan ektopik
- p. Perilaku / Psikiatrik:
 - Kasar atau agresif
 - Ancaman langsung terhadap diri sendiri atau orang lain
 - Membutuhkan pengkekangan
 - Agitasi atau agresi berat

3. ATS 3 :

- a. Hipertensi berat
- b. Kehilangan cukup banyak darah – apapun penyebabnya
- c. Sesak napas sedang
- d. Saturasi O₂ 90 – 95
- e. Kadar Gula Darah > 16 mmol/l
- f. Riwayat kejang (saat ini sadar)
- g. Semua demam pada pasien immunosupresi misalnya pasien onkologi, Rx steroid
- h. Muntah terus menerus
- i. Dehidrasi
- j. Cedera kepala dengan kehilangan kesadaran yang singkat – saat ini sadar
- k. Nyeri sedang sampai berat – apapun penyebabnya, yang membutuhkan analgesik
- l. Nyeri dada non-kardiak dengan tingkat keparahan sedang
- m. Nyeri perut tanpa ciri-ciri risiko tinggi – tingkat keparahan sedang atau pasien usia > 65 tahun
- n. Trauma ekstremitas sedang – deformitas, laserasi yang parah,
- o. Ekstremitas – Perubahan sensasi, tidak ada pulsasi
- p. Trauma – Riwayat penyakit risiko tinggi tanpa risiko tinggi lainnya
- q. Neonatus stabil
- r. Anak berisiko
- s. Perilaku / Psikiatrik:
 - Sangat tertekan, risiko menyakiti diri sendiri
 - Psikotik akut atau gangguan pikiran
 - Krisis situasional, sengaja menyakiti diri sendiri
 - Agitasi / menarik diri / berpotensi agresif

4. ATS 4 :

- a. Perdarahan ringan
- b. Aspirasi benda asing, tanpa distress pernapasan
- c. Cedera dada tanpa nyeri pada tulang iga atau distress pernapasan
- d. Kesulitan menelan, tanpa distress pernapasan

- e. Cedera kepala ringan, tidak kehilangan kesadaran
- f. Nyeri sedang, dengan beberapa faktor risiko
- g. Muntah atau diare tanpa dehidrasi
- h. Inflamasi atau benda asing pada mata – penglihatan normal
- i. Trauma ekstremitas minor – pergelangan kaki terkilir, kemungkinan patah tulang, laserasi tidak terkomplikasi yang membutuhkan investigasi atau intervensi – tanda vital normal, nyeri ringan / sedang
- j. Gips terlalu ketat, tanpa kerusakan neurovaskuler
- k. Sendi bengkak dan panas
- l. Nyeri perut tidak spesifik
- m. Perilaku / Psikiatrik :
Masalah kesehatan mental semi-urgent
Dalam observasi dan/atau tidak ada risiko langsung terhadap diri sendiri maupun orang lain.

5. ATS 5 :

- a. Nyeri minimal tanpa ciri-ciri berisiko tinggi
- b. Riwayat penyakit risiko rendah dan saat ini asimtomatik
- c. Gejala minor dari penyakit stabil yang ada
- d. Gejala minor dari kondisi dengan risiko rendah
- e. Luka minor – lecet kecil, laserasi ringan (tidak membutuhkan jahitan)
- f. Dijadwalkan kontrol misalnya pada kontrol luka, perban kompleks
- g. Imunisasi
- h. Perilaku / Psikiatrik :
Pasien yang dikenal dengan gejala kronis
Krisis sosial, pasien baik secara klinis

Untuk pasien anak-anak digunakan standard yang berbeda, karena kondisi pada anak jauh lebih berbahaya daripada dewasa

Triage Anak < 6 Bulan

	RISIKO TINGGI	RISIKO SEDANG
Pemberian makanan	< ½ normal	1/2 - 2/3 normal
<i>Arousal</i> / Tingkat kewaspadaan (SSP)	Sering mengantuk Penurunan aktivitas Konvulsi Tangisan lemah	Kadang mengantuk
Pernapasan	Apnea atau Sianosis	Sesak napas
Sirkulasi	Kulit pucat dan panas	Kulit pucat
Output cairan	Muntah kehijauan < 4 x popok basah / hari	>5 x muntah dalam 24 jam Kencing kurang dari biasanya
Feses	Tinja berdarah	

ALUR DALAM PROSES TRIAGE

1. Pasien datang diterima petugas / paramedis IGD

2. Diruang triase dilakukan anamneses dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya oleh perawat.
3. Bila jumlah penderita / korban yang ada lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan di luar ruang triase (di depan gedung IGD)
4. Setelah diseleksi, dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Ditangani di tempat periksa/tempat tindakan sesuai dengan kondisi klinisnya (bedah/non-bedah/obstetriginekologi).
 - b. Jika didapatkan kegawatdaruratan yang mengarah pada kondisi *cardiac arrest* dan/atau *respiratory arrest* segera ditangani di ruang resusitasi ATS 1.
 - c. Jika pasien yang datang termasuk ATS 4 dan ATS 5 datang pada jam kerja maka diarahkan ke Instalasi Rawat Jalan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya dan bilamana perlu dianjurkan untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Jika pasien datang di luar jam kerja maka dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya setelah kasus-kasus gawat darurat terlayani.
 - d. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia (*death on arrival*). Dipastikan terlebih dahulu bahwa pasien memang sudah meninggal dunia, untuk kemudian bilamana perlu dibawa ke kamar jenazah.

Kategori	Waktu respon maximum
ATS 1	Segera
ATS 2	10 menit
ATS 3	30 menit
ATS 4	60 menit
ATS 5	120 menit

5.3 ASESMEN GAWAT DARURAT

Asesmen yang efektif menghasilkan keputusan tentang tindakan segera dan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien untuk tindakan darurat, asuhan terencana, bahkan jika kondisi pasien berubah. Asesmen pasien merupakan proses berkelanjutan, dinamis dan dikerjakan di instalasi / unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan unit pelayanan lainnya. Asesmen pasien terdiri dari 3 proses utama dengan metode IAR :

- a. Mengumpulkan data dan informasi (huruf I) tentang hal-hal sesuai d sd n, tersebut dibawah. Pada SOAP adalah S–Subyektif dan O–Obyektif.
- b. Analisis data dan informasi (huruf A) , yaitu melakukan analisis terhadap informasi yang menghasilkan diagnosis, masalah, dan kondisi, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pada SOAP adalah A-Asesmen.
- c. Membuat Rencana (huruf R), yaitu menyusun solusi untuk mengatasi / memperbaiki kelainan kesehatan sesuai butir b . Pelaksanaan R adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah teridentifikasi. Pada SOAP adalah P– Plan.

Asesmen awal masing-masing pasien gawat darurat meliputi :

- a. status fisik
- psiko-sosio-spiritual
- ekonomi
- g. riwayat kesehatan pasien.
- h. riwayat alergi,
- i. asesmen nyeri,
- j. risiko jatuh,
- k. asesmen fungsional,
- l. risiko nutrisi
- l. risiko nutrisi
- m. kebutuhan edukasi ,
- n. Perencanaan Pemulangan Pasien (Discharge Planning)

Asesmen awal seorang pasien, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat merupakan proses yang penting untuk identifikasi kebutuhan pasien untuk memulai proses asuhan pasien. Proses asesmen awal memberikan informasi perihal:

- Pemahaman asuhan yang diinginkan oleh pasien

- Pemilihan asuhan paling baik untuk pasien
- Diagnosis awal, dan
- Pemahaman respons pasien terhadap asuhan sebelumnya

Untuk mendapatkan informasi ini, asesmen awal melakukan evaluasi kondisi pasien melalui pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatannya. Asesmen psikologis menentukan status emosional pasien (misalnya, jika pasien depresi, takut jiwanya terancam, suka berkelahi, membahayakan diri sendiri atau orang lain).

Mengumpulkan informasi tentang pasien tidak bermaksud “menggolongkan” pasien kedalam “satu golongan tertentu”. Tetapi status sosial, kultur, spiritual, ekonomi, dari pasien merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap respons pasien terhadap penyakit dan tindakan pengobatan.

Keluarga akan membantu dalam proses asesmen dan untuk memahami keinginan pasien dan pilihannya dari proses asesmen. Faktor ekonomi dikaji sebagai bagian asesmen sosial, atau asesmen ekonomi terpisah jika pasien dan keluarganya bertanggung jawab terhadap semua atau sebagian biaya asuhan selama dirawat atau sesudah keluar rumah sakit. Banyak profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan diberi kewenangan yang berbeda-beda terlibat dalam asesmen pasien. Faktor terpenting adalah asesmen dilakukan lengkap dan tersedia bagi mereka yang bekerja untuk memberikan asuhan.

Asesmen sangat bermanfaat jika mempertimbangkan kondisi, umur, kebutuhan kesehatan, termasuk permintaan keinginan pasien. Proses akan dilaksanakan sangat efektif jika berbagai profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien berkerja sama.

5.4 RENCANA ASUHAN

Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat kualitas asuhan yang sama di rumah sakit. Untuk melaksanakan prinsip kualitas asuhan yang setingkat mengharuskan pimpinan merencanakan dan mengoordinasi pelayanan pasien. Secara khusus, pelayanan yang diberikan kepada populasi pasien yang sama pada berbagai unit kerja dipandu oleh regulasi yang menghasilkan pelayanan yang seragam. Sebagai tambahan, pimpinan harus menjamin bahwa rumah sakit menyediakan tingkat kualitas asuhan yang sama setiap hari dalam seminggu dan pada setiap shift. Regulasi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membentuk proses pelayanan pasien dan dikembangkan secara kolaboratif.

Asuhan pasien yang seragam terefleksi sebagai berikut:

- 1) akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai dan diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari setiap minggu atau waktunya setiap hari;
- 2) penggunaan alokasi sumber daya yang sama, antara lain staf klinis dan pemeriksaan diagnostik untuk memenuhi kebutuhan pasien pada populasi yang sama;
- 3) pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, contoh pelayanan anestesi sama di semua unit pelayanan di rumah sakit;
- 4) pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang setara di seluruh rumah sakit;
- 5) penerapan serta penggunaan regulasi dan form dalam bidang klinis antara lain metode asesmen IAR (Informasi, Analisis, Rencana), form asesmen awal asesmen ulang, PPK, alur klinis terintegrasi/clinical pathway, pedoman manajemen nyeri, dan regulasi untuk berbagai tindakan antara lain water sealed drainage, pemberian transfusi darah, biopsi ginjal, pungsi lumbal, dsb.

Asuhan pasien yang seragam menghasilkan penggunaan sumber daya secara efisien dan memungkinkan membuat evaluasi hasil asuhan (outcome) untuk asuhan yang sama di seluruh rumah sakit.

5.5 MENGELOLA ALUR

A. DPJP

Asuhan pasien diberikan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang bekerja sebagai Tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). DPJP berperan sebagai ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (clinical leader). DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yg sesuai dengan proses UU untuk mengatur kesinambungan asuhan selama pasien berada di rumah sakit, maka DPJP bertanggung jawab sebagai berikut :

- a) Mengelola Pasien Sesuai Dgn Kewenangan Klinis
- b) Melakukan Koordinasi Dan Kesinambungan Asuhan
- c) Bertugas Dalam Seluruh Fase Asuhan Rawat Inap Pasien Serta Teridentifikasi Dalam Rekam Medis Pasien.

Pengaturan Perpindahan Tanggung Jawab

Perpindahan Tanggung Jawab adalah koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama adalah sebagai berikut:

- a. Rawat Bersama Adalah Bila Dilaksanakan Rawat Bersama Ditetapkan DPJP Utama Sebagai Koordinator
- b. Asuhan Pasien adalah Staf RS yang berhak memberi rencana asuhan pasien terkait perkembangan kondisi pasien setiap waktu.
- c. Konsul adalah melaporkan keseluruhan kepada penanggung jawab pelayanan (DPJP) kondisi awal masuk pasien meliputi data subyektif, data obyektif dan pemeriksaan penunjang.

Alih Rawat adalah pengalihan penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke satu DPJP lainnya yang disebabkan karena kondisi/ perjalanan penyakit pasien yang dirawat.

B. SKRINING PASIEN MASUK RAWAT INAP

Pada waktu skrining dan pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien.

Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan/ komplikasi, misalnya antara lain kasus luka tusuk dalam diberikan ATS dan kasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

Kriteria dibagi menjadi 3 pelayanan :

Unit	Ruang	Kamar	Kriteria
Inra lantai 1	Maternitas	Cempaka	Obstetri Ginekologi
		Bougenvil	Obstetri Ginekologi
	Perinatologi		Bayi baru lahir
Inra lantai 2	Blok A	Anggrek	Pasien VVIP Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, isolasi
		Viola	Pasien VVIP Interna, Syaraf, Paru, Obgin, THT, Bedah, airborne disease, isolasi

	Blok B	Anggrek	Pasien VIP Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, THT, Bedah, Cardio
		Bougenvill	Pasien Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, Cardio, isolasi
		Cempaka	Pasien Interna, syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, Cardio
		Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, Cardio
Irna Lantai 3	Blok A	Cempaka	Pasien Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, Cardio
		Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, Anak, THT, Bedah, Cardio
		Isolasi	Airborne disease

Tata Laksana Pelayanan Pasien Rawat Inap

1 Pasien masuk ruang rawat inap(SPO) :

1) Ruang rawat inap tersedia

Kamar tidur yang kosong dan siap untuk di tempati.

- Pasien dari IRJA/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
- Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
- Keluarga memilih ruang rawat inap yangdikehendaki
- Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendakipasien.
- Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasienMRS.
- Pasien mendapatkan nomor register rawatinap.
- Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan dan tata tertib RS saat pasien di rawat inap
- Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJA/IGD.
- Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJ/IGD dan perawat rawat inap.
- Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap.
- Serah terima di *nursestation*.
- Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi &orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
- Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawatinap.

2) Ruang rawat inap tidaktersedia

a) Penuh

- Pasien dari IRJA/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
- Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inapbeserta tarifnya.
- Keluarga memilih ruang rawat inap yangdikehendaki
- Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yangdikehendaki pasien. Bila ruang yang di kehendaki penuh, ditawarkan memilih ruanglinglain.
- Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasienMRS.
- Pasien mendapatkan nomor register rawatinap.
- Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan & tatatertib RS saat pasien di rawat inap
- Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJ/IGD.
- Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJ/IGD dan perawat

rawat inap.

10. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJ/IGD.
11. Serah terima di *nurse station*.
12. Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
13. Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap.

b) Tunggu pasien pulang < 2jam

- 1 Pasien dari IRJ/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
- 2 Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
- 3 Keluarga memilih ruang rawat inap yang dikehendaki
- 4 Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendaki pasien. Bila ruang yang dikehendaki ada tetapi masih ada pasien yang akan pulang, keluarga ditawarkan apakah akan memilih ruang lain atau tidak. Bila tidak memilih ruang lain, untuk sementara pasien menunggudi IRJ/IGD.
- 5 Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasien MRS.
- 6 Pasien mendapatkan nomor register rawat inap.
- 7 Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan dan tata tertib RS saat pasien di rawat inap.
- 8 Petugas pendaftaran telpon petugas IRJ / IGD kalau pasien menunggu sampai ruangan siap.
- 9 Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJ/IGD bila ruangan sudah siap.
- 10 Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJ/IGD dan perawat rawat inap.
- 11 Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJ/IGD.
- 12 Serah terima di *nurse station*.
- 13 Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
- 14 Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap.

c) Tunggu pasien pulang > 2jam

- 1 Pasien dari IRJ/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
- 2 Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
- 3 Keluarga memilih ruang rawat inap yang dikehendaki
- 4 Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendaki pasien. Bila ruang yang dikehendaki ada tetapi masih ada pasien yang rencana pulang, keluarga ditawarkan memilih ruang lain dan ruang yang dikehendaki bias dipesan setelah pasiennya pulang. Selama pasien belum mendapatkan ruang yang dipesan, pasien dikenakan tarif sesuai ruang yang ditempati saat itu.
- 5 Diberikan tulisan papan tunggu ruangan
- 6 Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasien MRS.
- 7 Pasien mendapatkan nomor register rawat inap.
- 8 Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan dan tata tertib RS saat pasien di

- rawat inap.
- 9 Petugas pendaftaran telpon petugas IRJA/IGD kalau ruang yang dipesan keluarga masih ada pasien & sementara memilih ruang lain sampai ruang yang dipesan ada.
 - 10 Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJA/IGD.
 - 11 Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJA/IGD dan perawat rawat inap.
 - 12 Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJA/IGD.
 - 13 Serah terima di *nurse station*.
 - 14 Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
 - 15 Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap.

C. INDIKASI MASUK DAN INDIKASI KELUAR ICU

Penentuan indikasi pasien yang masuk ke ICU dan keluar dari ICU serta pasien yang tidak dianjurkan untuk dirawat di ICU ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria masuk ICU

- 1) Sistem Kardiovaskuler :
 - a) *Sindroma Koroner Akut* (SKA) : tanpa atau dengan komplikasi dan mungkin disertai penyakit penyerta lainnya
 - b) Syok Cardiogenik
 - c) Kegawatan irama jantung
 - d) Gagal jantung dan paru akut
 - e) Kegawatan hipertensi disertai kegawatan kardiovaskuler
 - f) Kegawatan penyakit jantung katup
 - g) Kegawatan penyakit jantung kongenital
 - h) Kegawatan vaskuler (diseksi aorta, emboli paru, sumbatan pembuluh darah vena dalam dan arteri veriver)
 - i) Kegawatan kardiovaskuler lainnya (endokarditis, miocarditis, tamponade jantung, trauma jantung)
 - j) Pasien kardiovaskuler yang memerlukan pemantauan hemodinamik untuk evaluasi terapi
 - k) Serangan asma berat
 - l) Status epileptikus
 - m) Anemia gravis dengan hemodinamik tidak stabil
 - n) Bronkopneumonia dengan hemodinamik tidak stabil
 - o) Kelainan jantung kritikal
 - p) Gagal jantung pada anak
- 2) Sistem Pernafasan
Pneumonia, COPD, asma, TBC yang sudah terjadi komplikasi sampai ke syok sepsis, dan ada gagal nafas tetapi tanpa menggunakan ventilator
- 3) Sistem Syaraf
 - 1) CVA *Bleeding* dengan penurunan kesadaran
 - 2) CVA *Trombosis* yang meluas
 - 3) GBS (Guillain Barre syndrome) dengan gejala sesak nafas

a. Kriteria Keluar

- 1) Pasien sudah stabil yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat tentang pernafasan (C,A,B).
- 2) Pasien meninggal

- b. Yang tidak perlu masuk ICU
 - 1) Pasien dengan fase terminal suatu penyakit (seperti kanker stadium akhir)
 - 2) Pasien/keluarga yang menolak untuk dirawat di ICU (atas dasar *inform consent*)

D. TATA LAKSANA SISTEM RUJUKAN

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien.

Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam kerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal

1. Ada regulasi tentang rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.
3. Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.
4. Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima

TATALAKSANA RUJUKAN

1. Petugas Penanggung Jawab
 - a. Dokter IGD
 - b. Perawat IGD / PPA
2. Perangkat Kerja
 - a. Ambulan
 - b. Formulir persetujuan tindakan rujuk
 - c. Formulir rujukan
3. Tata Laksana Sistem Rujukan IGD

Daftar rumah sakit dan dokter penyedia pelayanan kesehatan dilingkungan rumah sakit Prima Husada yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit dan populasi pasien rumah sakit Prima Husada.

Rujukan keluar rumah sakit dapat ditujukan kepada individu secara spesifik dan dar mana pasien berasal, seperti :

 - a. Alih Rawat / Rujuk
 - 1) Perawat IGD /PPA menghubungi rumah sakit yang akan dirujuk
 - 2) Dokter jaga IGD memberikan informasi pada dokter jaga rumah sakit rujukan mengenai keadaan umum pasien (SPO - IGD)
 - 3) Bila tempat telah tersedia di rumah sakit rujukan, perawat IGD menghubungi driver ambulance RS Prima Husada sesuai kondisi pasien
 - b. Pemeriksaan Diagnostik
 - 1) Pasien / keluarga pasien dijelaskan oleh dokter jaga mengenai tujuan pemeriksaan diagnostik, bila setuju maka keluarga pasien harus mengisi *informed consent*
 - 2) Perawat IGD/ PPA menghubungi rumah sakit rujukan
 - 3) Perawat IGD/ PPA menghubungi driver ambulance RS Prima Husada
 - c. Spesimen
 - 1) Pasien / keluarga pasien dijelaskan mengenai tujuan pemeriksaan specimen
 - 2) Bila keluarga setuju maka harus mengisi *inform consent*
 - 3) Dokter jaga mengisi formulir pemeriksaan, dan diserahkan kepetugas laboratorium.

- 4) Petugas laboratorium melakukan rujukan ke laboratorium yang dituju

E. TATA LAKSANA AMBULANCE (TRANSPORTASI PASIEN)

1. Permintaan ambulance transfer/rujuk H-1
 - a. unit mengisi form permintaan ambulance
 - b. form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien ke kasir
 - c. Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance dan memberikan kekeluarga pasien
 - d. Form permintaan ambulance diserahkan keluarga ke unit
 - e. unit menyerahkan form permintaan ambulance ke pos 7B
 - f. Saat akan digunakan mengantar pasien, driver memberikan form ke IGD
2. Permintaan ambulance untuk transfer/rujuk cito :
 - a. Unit mengisi form permintaan ambulance dan menghubungi bagian IGD untuk Permintaan ambulance
 - b. Petugas IGD menghubungi pengemudi ambulance yang sedang berjaga
 - c. Form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien kekasir
 - d. Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance dan memberikan kekeluarga pasien
 - e. Form permintaan ambulan diserahkan keluarga ke unit
 - f. Unit konfirmasi Pengemudi ambulance kalau semua sudah siap
 - g. perawat mengantar pasien ke ambulance
 - h. perawat ke IGD memberikan form permintaan ambulance, mencatat di buku permintaan ambulance dan mengambil peralatan ambulance
 - i. perawat mengingatkan keluarga pasien untuk mengisi kuisioer
 - j. pengemudi memberikan kuisioer ke bagian pengelolaan pelanggan setelah kembali dari pengantaran
3. Persyaratan kendaraan transfer/rujuk :
 1. Teknis
 - 1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak;
 - 2) Ruang pasien mudah mencapai dari tempat pengemudi
 - 3) Tempat duduk bagi petugas di ruang pasien;
 - 4) Dilengkapi sabuk pengaman;
 - 5) Ruang pasien cukup luas untuk sekurang – kurangnya 2(dua) stretcher;
 - 6) Gantungan infuse terletak sekurang – kurangnya 90 cm diatas tempat pasien;
 - 7) Stop kontak khusus untuk 220 volt DC di ruang pasien;
 - 8) Lampu ruangan secukupnya;
 - 9) Lemari obat dan peralatan;
 - 10) Sirine 1(satu) nada;
 - 11) Lampu rotator warna merah, biru (biru masih dalam proses untuk pelepasan);
 - 12) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang yang berlaku;
 - 13) Tanda pengenal ambulance transportasi dari bahan yang memantulkan sinar;
 - 14) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia.
 2. Medis
 - 1) Tabung oksigen dengan peralatannya;
 - 2) *Box emergency*;
 - 3) Monitor
 3. Petugas
 - 1) 1 (satu) pengemudi dengan kemampuan P3K dan komunikatif;
 - 2) 1(satu) perawat dengan kemampuan PPGD.
 4. Tata tertib
 - 1) Selama mengangkut pasien hanya boleh menggunakan lampu rotator (untuk pasien pulang/APS tanpa lampu rotator);

-
- 2) Semua perlengkapan lalu lintas harus ditaati;
 - 3) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku;
 - 4) Kecepatan kendaraan setinggi 40km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan.
4. Ambulance jenazah
 - a. Persyaratan ambulance jenazah :
 - 1) Teknis
 - a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak;
 - b) Brangkar dilengkapi sabuk pengaman;
 - c) Lampu ruangan secukupnya;
 - d) Sirine 1(satu) atau 2(dua) nada;
 - e) Lampu rotator warna merah dan biru;
 - f) Ruangan jenazah terpisah dari ruang kemudi;
 - g) Tempat duduk atau duduk lipat minimal 4 (empat) orang di samping jenazah;
 - h) Air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah;
 - i) Tanda pengenal ambulance atau kereta jenazah dari bahan yang memantulkan sinar;
 - j) Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Petugas
1 (satu) pengemudi yang komunikatif;
 - 3) Tata tertib
 - a) Sirine hanya digunakan saat bergerak dalam iringan jenazah dan mematuhi peraturan lalu lintas tentang konvoi;
 - b) Apabila tidak dalam iringan hanya boleh menghidupkan lampu rotator;
 - c) Semua perlengkapan lalu lintas harus ditaati;
 - d) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku;
 - e) Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan

5.6 TATA LAKSANA PASIEN MELARIKAN DIRI

A. Pengertian

Tatacara penanganan pasien melarikan diri (pasien dianggap meninggalkan rumah sakit tanpa seizin dihitung $\pm$ 3 jam sejak waktu pergantian petugas)

B. Tatalaksana

Perawat Segera melapor :

1. Ke keamanan secara tertulis pada buku khusus laporan keamanan dengan data pasti tentang pasien meliputi :
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Meninggalkan ruangan tanggal : Jam.....
 - d. Ciri-ciri khusus
2. Ke Sub.Bagian Billing dan Kasir memberikan data perincian biaya pemakaian obat dan alkes, sewa alat, kwitansi dokter, pemeriksaan yang belum diperinci, konsultasi gizi dan lain-lain.
3. Kepala ruangan atau penanggungjawab ruangan melaporkan kejadian pasien melarikan diri melalui telepon disusul laporan tertulis kronologis kejadian kepada:
 - a. Dokter yang merawat/dokter jaga.
 - b. Kepala bidang perawatan.
 - c. Sub.Bag.Administrasi pasien (AP) dengan melampirkan data yang belum masuk :
 - 1) Pemakaian obat dan Alkes habis pakai.
 - 2) Jasa dokter.
 - 3) Pemeriksaan penunjang.

4. Keamanan/ Satpam :

- a. Mencari alamat pasien yang bersangkutan.
- b. Membuat berita acara pasien kabur
- c. Melaporkan berita acara kepada Kepala keamanan dengan tembusan dan Ka.Bid.Keperawatan.

BAB VI LOGISTIK

Pengelolaan obat dan alat kesehatan / alkes meliputi pemesanan, pengambilan, penyimpanan dan pencatatan obat / alkes untuk pasien – pasien IGD.

Mekanisme pengadaan obat dan alat medis di IGD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan alat
 - a. Lembaran *stock* obat
 - b. Buku keluar / masuk alat
 - c. Buku inventaris alat
 - d. Blangko pemesanan obat dan alkes
2. Setiap hari petugas / pekaya pagi menyeterilkan dan mengambil kembali setelah disterilkan untuk disimpan pada tempatnya.
3. Pemesanan alat kesehatan dilakukan oleh perawat penanggung jawab dinas pagi setiap hari dengan mengisi blanko pemesanan alkes yang ditandatangani Kepala perawat / Kepala IGD dengan jumlah yang sesuai pengeluaran / kebutuhan, kecuali bila jatuh pada hari libur, pemesanan dilakukan sehari sebelumnya.
4. Pengadaan alat umum :
 - a. Petugas IGD membuat permintaan ke bagian Pengadaan, dengan mengisi Formulir Pengambilan Barang yang ditandatangani oleh Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat atau Kepala Instalasi Gawat Darurat.
 - b. Formulir diserahkan ke Bagian Gudang.
5. Pengadaan alat – alat kesehatan :
 - a. Instalasi Gawat Darurat mengajukan permintaan barang dengan mengisi formulir permintaan barang. Formulir tersebut terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat untuk diketahui, dipertimbangkan dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Kepala Bidang Pelayanan Medik.
 - b. Permintaan barang yang telah disetujui oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik, selanjutnya diajukan kepada Bagian Pengadaan, untuk dipertimbangkan dan pengesahan.
 - c. Bagian pengadaan melakukan negoisasi penawaran harga untuk mendapat kesepakatan harga dengan pemasok.
 - d. Bagian pengadaan memberi perintah kepada bagian / petugas pembelian, untuk membeli barang – barang sesuai kebutuhan bagian yang meminta. Dalam hal kebutuhan barang – barang rutin yang telah dilakukan perjanjian kerjasama, maka pembelian dapat langsung di lakukan ke pemasoknya, setelah ada pengesahan dari Bagian Pengadaan.
 - e. Bagian / petugas pembelian melakukan transaksi atas pembelian barang – barang sesuai permintaan baik untuk barang – barang rutin atau barang – barang yang non *stock*.
 - f. Pemasok mengantar barang ke RS. Prima Husada sesuai pesanan dan barang tersebut diterima oleh bagian, Bagian Pengadaan memeriksa apakah barang – barang tersebut sesuai dengan pesanan baik jenis maupun jumlah pesanan.
 - g. Kemudian bagian gudang mendistribusikan barang kepada Instalasi Gawat Darurat.
 - h. Untuk pengambilan barang di gudang yang sudah diajukan, Petugas IGD melakukan prosedur pada permintaan alat – alat umum diatas.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 PENGERTIAN

Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman.

Sistem tersebut meliputi :

1. Asesmen risiko
2. Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien
3. Pelaporan dan analisis insiden
4. Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
5. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko

Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh :

1. Kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan
2. Tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

s

7.2 TUJUAN

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

7.3 STANDAR KESELAMATAN PASIEN

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

7.4 KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)

ADVERSE EVENT :

Adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah

KTD yang tidak dapat dicegah

Unpreventable Adverse Event :

Suatu KTD yang terjadi akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan mutakhir

KEJADIAN NYARIS CEDERA (KNC)

Near Miss :

Adalah suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (*commission*) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (*omission*), yang dapat mencederaikan pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi :

- Karena “ keberuntungan”
- Karena “ pencegahan ”
- Karena “ peringanan ”

KESALAHAN MEDIS

Medical Errors:

Adalah kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien

KEJADIAN SENTINEL

Sentinel Event :

Adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah.

Pemilihan kata “sentinel” terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (seperti, amputasi pada kaki yang salah) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.

7.5 TATA LAKSANA

1. Memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien
2. Melaporkan pada dokter jaga IGD
3. Memberikan tindakan sesuai dengan instruksi dokter jaga
4. Mengobservasi keadaan umum pasien
5. Mendokumentasikan kejadian tersebut pada formulir “Pelaporan Insiden Keselamatan”

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 PENGERTIAN

Keselamatan kerja merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat kerja / aktifitas staf lebih aman. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan pribadi ataupun rumah sakit.

8.2 TUJUAN

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

8.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN STAF

1. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu :
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi.
 - b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kacamata, sepatu boot/alas kaki tertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll.
 - c. Melakukan perasat yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, mis: memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
 - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah menangani pasien.
2. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius
3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
4. Menggunakan baju kerja yang bersih
5. Melakukan upaya-upaya medis yang tepat dalam menangani kasus :
 - a. HIV / AIDS (sesuai prinsip pencegahan infeksi)
 - b. Flu burung

Kewaspadaan standar staf / petugas IGD dalam menghadapi penderita dengan dugaan flu burung adalah :

- 1) Cuci tangan
Cuci tangan dilakukan dibawah air mengalir dengan menggunakan sikat selama $\pm$ 5 menit, yaitu dengan menyikat seluruh telapak tangan maupun punggung tangan.
- 2) Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah memeriksa penderita.
- 3) Memakai masker N95 atau minimal masker badan
- 4) Menggunakan pelindung wajah / kaca mata goggle (bila diperlukan)
- 5) Menggunakan apron / gaun pelindung
- 6) Menggunakan sarung tangan
- 7) Menggunakan pelindung kaki (sepatu boot)
- 8) Hepatitis B / C (sesuai prinsip pencegahan infeksi)

8.4 PRINSIP KESELAMATAN KERJA

Prinsip utama prosedur Universal Precaution dalam kaitan keselamatan kerja adalah menjaga higiene sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan pokok yaitu :

-
1. Cuci tangan guna mencegah infeksi silang
 2. Pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksi yang lain.
 3. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai
 4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan
 5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.

BAB IX PENGENDALIAN MUTU

Beberapa indikator mutu dalam pelayanan gawat darurat sebagai berikut :

1. **Angka Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat Darurat (KPPGD)**

Pelayanan Pertama Gawat Darurat dikatakan terlambat apabila pelayanan terhadap penderita gawat dan atau darurat yang dilayani dengan tindakan *Life Saving* oleh petugas gawat darurat lebih dari 5 menit.

Petugas gawat darurat adalah petugas yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat, yang telah dilatih PPGD.

Tindakan Darurat atau Life Saving adalah tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa manusia yang sedang terancam karena penyakit atau luka-luka yang dideritanya.

Rumus :

$$\text{KPPGD} = \frac{\text{Banyaknya penderita gawat darurat yang dilayani dalam 5 menit per bulan}}{\text{Total penderita gawat darurat pada bulan tsb}} \times 100\%$$

Analisis harus dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali secara terus menerus. Yang harus disimpulkan dari analisis ini adalah kecenderungan (trend) dari Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat Darurat.

2. **Angka Kematian (AK) di IGD**

Rumus :

$$\text{AK} = \frac{\text{JUMLAH KEMATIAN}}{\text{Jumlah Pasien IGD}} \times 100\%$$

Angka kematian ini harus dikumpulkan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan angka kematian ini dari waktu ke waktu. Tidak dimasukkan didalam angka kematian ini Death On Arrival (DOA).

BAB X

PENUTUP

Demikianlah buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat ini disusun. Kami mengajak semua pihak yang bekerja di RS Prima Husada untuk dapat bersama-sama membina dan mengembangkan sistem pelayanan di IGD. Semua petugas baik tenaga medis, paramedis, maupun non medis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan gawat darurat hendaknya selalu menaati ketentuan yang telah digariskan di dalam buku pedoman ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

DENAH LANTAI 01
SKALA 1:200 PAPER A3